全スタッフ（看護師・薬剤師・リハビリ・事務・介護職）

認知バイアスと日常の判断 ― なぜ優秀な人でも間違えるのか

全スタッフ向け勉強会スライド（20分）

参考文献

2026-03-30 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

なぜ優秀な人でも判断を間違えるのか

> *「ICUの剖検研究（Podbregar 2001）では、医師が”完全に確信がある”と評価した診断でも、**約4割で剖検の所見が食い違っていました**（治療を変えうる見逃しは約9%）。確信の強さは正しさを保証しません。これは能力の問題ではなく、脳の仕組みの問題です」*

- 航空業界の教訓: パイロットの「ミス」を「ヒューマンファクター」として再定義
  - 結果: 航空の安全性向上に寄与したとされる
- 医療でも同じアプローチが使える
- 今日のテーマ: **「注意しましょう」ではなく「仕組みで防ごう」**

学習目標

この勉強会の後、あなたは以下ができるようになります:

1. **説明できる**: 認知バイアスが「個人のミス」ではなく「脳の仕組み」であることを説明できる
2. **実践できる**: 日常業務で1つ、バイアスを防ぐ具体的な方法を実践できる
3. **評価できる**: チームでの安全確認の仕組みが機能しているか振り返れる

速い脳と遅い脳

私たちの脳には2つのモードがあります:

	速い脳（System 1）	遅い脳（System 2）
スピード	一瞬で判断	じっくり考える
エネルギー	省エネ	エネルギー大量消費
得意なこと	パターン認識、直感	論理的思考、計算
日常の例	「あ、この人怒ってる」と表情で察する	「78×34は…」と計算する
仕事の例	「いつもと様子が違う」と感じる	薬の量をダブルチェックする

- **速い脳は優秀** — 仕事の大半はこれで回っている
- **でも時々間違える** — それが「認知バイアス」
- **大事なポイント**: バイアスは**誰にでも起きる**。頭が良い・悪いの問題ではない

日常業務で起きるバイアス4つ

1. 確認バイアス ―「思い込みメガネ」

- **意味:** 一度「こうだ」と思うと、それを裏付ける情報ばかり目に入る
- **仕事での例:** 「この患者さんはいつも大げさ」→ 本当の痛みを聞き逃す
- **日常の例:** 「あの店はまずい」→ 美味しい料理も気づかない

2. アンカリング ―「最初の情報に引きずられる」

- **意味:** 最初に聞いた情報が基準になって、そこから離れられない
- **仕事での例:** 申し送りで「発熱なし」→ その後37.8℃出ても「大したことない」と判断
- **日常の例:** セール「50%OFF」→ 元値が高くても「お得」と感じる

日常業務で起きるバイアス4つ（続き）

3. 利用可能性バイアス ―「最近の記憶に引っぱられる」

- **意味:** 最近経験したこと・印象的なことが「よくあること」に感じる
- **仕事での例:** 先週転倒事故があった → 今週は転倒ばかり気にして、他のリスクを見落とす
- **日常の例:** 飛行機事故のニュースを見た直後 → 飛行機が怖くなる（実際は車の方が危険）

4. 過信 ―「わかったつもり」

- **意味:** 自分の判断を実際以上に正しいと思ってしまう
- **仕事での例:** 「この薬は何度も扱ったから大丈夫」→ 確認を省略してインシデント
- **ベテランほど注意:** 経験が増えると「速い脳」で処理する割合が増え、確認を省きやすくなる

まとめ

4つのバイアスまとめ

バイアス	ひとことで言うと	仕事で起きやすい場面
確認バイアス	思い込みメガネ	申し送りの先入観、「いつもの」患者さん
アンカリング	最初に引きずられる	前の勤務帯からの情報、紹介状の診断名
利用可能性	最近に引っぱられる	インシデント直後の過剰反応、流行疾患
過信	わかったつもり	ルーティン業務の確認省略、ダブルチェック省略

共通点: どれも**速い脳の「省エネモード」**が原因

対策の基本: 意識的に**遅い脳のスイッチを入れる**タイミングを作る

チームでバイアスを防ぐ — 5つの問い

カンファレンスや申し送りで使える**「バイアスチェック5つの問い」**:

1. **「他に何かない？」** → 確認バイアス対策
   - 最初の判断以外の可能性を1つ考える
2. **「最初の印象に引きずられてない？」** → アンカリング対策
   - 前の情報をいったんリセットして見直す
3. **「最近の経験に影響されてない？」** → 利用可能性対策
   - 先週の出来事と今回の状況は別物
4. **「どれくらい確信がある？根拠は？」** → 過信対策
   - 「なんとなく大丈夫」を言語化する
5. **「もし間違っていたら、一番ありそうな理由は？」** → 総合チェック
   - 最悪のケースを先に想像する（プレモーテム）

ダブルチェックの本当の意味

> *「ダブルチェックは”2回確認すること”ではありません。”別の視点で確認すること”です」*

形骸化しやすいパターン:

- 同じ人が2回見る → 同じバイアスが2回働くだけ
- 「確認しました」にサインするだけ → チェックリスト疲れ

効果的なダブルチェック:

ダブルチェックの本当の意味（続き）

- 別の人が独立して確認する
- 「何を確認するか」を明確にする
- 「おかしい」と思ったら声を出す文化

Devil’s Advocate（あえて反論する役割）:

- チームの誰かが「本当にそれで合ってる？」と問う役を担う
- これは**批判ではなく安全の仕組み**

「自分もバイアスを持つ」= 強さ

> *「バイアスがあることは恥ずかしいことではありません。バイアスに気づける力こそが、プロフェッショナルの証です」*

- **メタ認知:** 自分の考え方について考えること
- バイアスを認められる人 = メタ認知能力が高い人
- 「私、思い込みで判断してたかも」と言えるチーム = **心理的安全性の高いチーム**

航空業界の文化転換:

- 昔:「機長に逆らうな」→ 多くの事故
- 今:「おかしいと思ったら誰でも声を上げる」→ 安全性の向上に寄与したとされる
- **CRM(Crew Resource Management):** チーム全体で安全を守る仕組み

グループワーク — うちのチームでできること

ワーク(5分): 3-4人グループで

> *「あなたの職場で、認知バイアスが原因で”ヒヤリ”とした経験はありますか？*
> *そのとき、どんな”仕組み”があれば防げたと思いますか？」*

- 付箋に1人1つ書いて、グループ内で共有
- グループで「明日から試せそうなこと」を1つ選ぶ

共有(3分): 各グループから1つずつ発表

ファシリテーターポイント:

- 「誰が悪い」ではなく「どんな仕組みが必要か」に焦点
- 小さなことでOK(「申し送りの最後に”他にない？”を追加する」等)

まとめ

明日からのアクション

職種別アクション例:

職種	明日からできること
看護師	申し送りの最後に「他に気になることは？」を追加
薬剤師	「いつもの薬」でもラベルを読む3秒ルール
リハビリ	「前回と同じメニュー」を選ぶ前に状態を再評価
事務	「いつもの手続き」でも変更点がないか確認
介護職	「いつもと違う」を感じたら、まず声に出す

持ち帰りメッセージ:

明日からのアクション（続き）

> *「バイアスは脳の仕組み。だから”気をつける”だけでは防げない。**仕組みで防ぐ。**」*

参考:

- Kahneman, D. (2011). ファスト&スロー
- Saposnik G et al. (2016). Cognitive biases associated with medical decisions: a systematic review. BMC Med Inform Decis Mak 16:138. PMID 27809908
- Podbregar M et al. (2001). Should we confirm our clinical diagnostic certainty by autopsies? Intensive Care Med 27:1750-1755. PMID 11810118